

18 - FMPP MOOCs - La fissure anale - Pr. Samlani

(0:00 - 0:27)

La fissure anal est une lésion superficielle siégeant au fond d'un des scions qui forment les plis radiés de l'anus. C'est une lésion qui se caractérise par une lésion, un mécanisme, une symptomatologie et un traitement particulier. C'est un motif fréquent en consultation, moins fréquent que la pathologie hémorragique.

(0:29 - 0:57)

Atteint tous les âges avec un sexe ratio égal à 1. La physiopathologie est multifactorielle et complexe. Elle semble regrouper des mécanismes traumatiques, mécanismes, ischémiques et une certaine hypertonie du sphincter anal interne. Sur cette diapositive, on a un résumé physiopathologique des différents mécanismes traumatiques, mécaniques, ischémiques et l'hypertonie du sphincter anal.

(0:58 - 1:27)

D'autres éléments interviennent, les troubles du transit, le stress et la douleur qui vont accentuer l'hypertonie de repos. Et bien sûr, l'ischémie et la fibrose qui vont bien sûr entraîner une évolution vers la fissure chronique. A l'interrogatoire, on peut retrouver une douleur anal qui est caractéristique parce qu'elle est en trois temps.

(1:28 - 1:51)

Déclenchée par le passage des sels, elle est décrite par le patient comme une douleur en lame de rasoir, suivie d'une rémission transitoire, puis par la réapparition d'une douleur. Le patient peut décrire des rectoragies, ce sont des rectoragies qui sont rouges, en sang frais, en fin de sel, qui ne sont pas mélangées au sel. Et il peut décrire également un prurite anal.

(1:52 - 2:17)

L'examen clinique doit être très doux. En dépliant les plis, sans toucher rectal, on peut retrouver une serration superficielle anoderme au-dessous de la ligne pectinée, en forme de larmes ou de raquettes, siégeant le plus souvent au niveau du pôle postérieur, plus rarement au niveau de la commissure antérieure. Il existe deux descriptions totalement différentes de la fissure anal.

(2:18 - 3:12)

L'une au cours de la phase aiguë, l'autre au cours de la phase chronique. La fissure aiguë, dite jeune, est comme celle que vous voyez ici, superficielle à berge fine, à fond rosé, en raquettes, évoluant à la cicatrisation en deux semaines, avec un risque de récurrence et de chronicisation si

elle n'est pas correctement traitée ou si les facteurs de risque persistent. Ceci est une fissure chronique.

Regardez comme les berges sont à tonnes. Et là, c'est en examinant le patient sous anesthésie générale, en mettant les écarteurs, qu'on voit une serratation fissuraire. Il faut toujours rechercher une cause secondaire devant une fissure anal persistante, malgré un traitement bien conduit, latéralisée et multiple.

(3:15 - 3:34)

Vous voyez ici une fissure latéralisée. Devant des douleurs, la défécation, c'est-à-dire quand le patient va à la selle, on peut penser à une thrombose hémorragitaire ou un abcès de la marche anal. Il est important de savoir que toute une serratation n'est pas une fissure anal.

(3:34 - 3:54)

Certains diagnostics différentiels doivent être reconnus, notamment la maïs de Crohn, les tumeurs, surtout le carcinome épidermoïde. Certaines usérations, notamment au cours des hémopathies malignes. Certaines usérations de causes infectieuses, la syphilis, l'herpès, la chlamydia.

(3:54 - 4:08)

Des usérations au cours de la chivée, au cours de la tuberculose. Des usérations traumatiques. Des usérations au cours de grattages ou au cours des lésions dermatologiques spécifiques, comme l'eczéma ou le lichen.

(4:09 - 4:24)

Des usérations iatrogènes, comme dans le cas de l'arthrothérapie. Et bien sûr, les malaises de système, le BSEP ou le feix d'air. Donc, toute usération n'est pas nécessairement une fissure anal.

(4:28 - 4:43)

La maladie de Crohn peut se manifester, dans un quart des cas, par des formes anopérinéales. Ces formes-là peuvent être révélatrices. Et parfois, les usérations peuvent être aussituées, creusantes.

(4:44 - 5:03)

La particularité de ces usérations, c'est qu'elles sont moins douloureuses et qu'elles sont atypiques. Ça veut dire qu'elles ne sont pas commissurales, postérieures, antérieures, mais qu'elles sont latéralisées et parfois multiples. Vous voyez ici, les fissures Crohniennes, à Berge-Hatton, latéralisées.

(5:06 - 5:31)

Au cours de la chivée, l'incidence des fissures peut atteindre 32%. Elles ont cette particularité qu'elles s'étendent au-delà des lignes pectinées, avec des lésions anorectales associées, d'autres usérations, des fistules, des abcès, avec une hypotonie du sphincter interne de l'anus. Les autres étiologies sont les infections sexuellement transmissibles, la tuberculose, qui est sous-estimée.

(5:32 - 5:52)

Généralement, on retrouve d'autres localisations et le diagnostic peut être confirmé par la NAPAD. Vous avez ici une fissure syphilitique. Sur cette diapositive, vous avez une fissuration à site omégalovirus.

(5:52 - 6:41)

Regardez au déplacement, comme elle est latéralisée, déchiquetée. Et sur cette diapositive, vous avez un carcinome épidermoïde du canal anal, qui est aussi un diagnostic différentiel de la fissure anal. Pour le traitement, les objectifs sont simples.

Il s'agit de soulager rapidement le patient et, bien sûr, d'éviter les récives. On dispose de plusieurs moyens, de moyens médicaux non spécifiques, tels que les anthalgiques, les laxatifs ou bien spécifiques, de moyens instrumentaux et de moyens chirurgicaux. Pour les fissures anales non compliquées, on traite par des anthalgiques, des régulateurs de transit, des topiques cicatrisants et on peut avoir recours à des scléroses.

(6:43 - 7:22)

Si échec, on peut avoir recours à des médicaments spécifiques qui vont agir en relâchant le sphincter interne. On peut avoir recours aux dérivés nitrés, à la toxine potulique, aux inhibiteurs calciques. Le traitement chirurgical a des indications bien précises.

Ce sont les fissures fistulisées, les fissures infectées, les fissures hyperalgiques et les fissures résistantes au traitement bien conduit. Parmi les traitements chirurgicaux, vous avez la sphinctérotomie latérale. C'est une sphinctérotomie partielle du sphincter interne, latéralisée à 3h ou à 9h.

(7:23 - 8:08)

Le but est de traiter l'hypertonie sphinctérienne à visée anthalgique, mais elle permet également la cicatrisation de la fissure. La présence d'une incontinence anal en est une contre-indication majeure, de même qu'une maladie de Crohn active ou un antécédent de rupture sphinctérienne. Sur cette diapositive, on voit ce que c'est qu'une fissure actemie.

Sous anesthésie générale, sous rachéanesthésie, on enlève la fissure, comme vous le voyez. On peut associer à cette intervention chirurgicale ce qu'on appelle une anoplastie, c'est-à-dire une couverture de la partie interne de la plaie par un abaissement muqueux. La principale contre-indication de ce geste est la présence d'une supérotation.

(8:10 - 8:26)

Je conclurai ce chapitre en disant que la fissure anal est une infection fréquente, de diagnostic relativement facile, qu'elle répond bien au traitement médical, bien conduit, qu'il faut connaître les diagnostics différentiels et que le chèque est tributaire d'un traitement chirurgical.